Клинические рекомендации

Мигрень у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**G43.0** — Мигрень без ауры [простая мигрень] **G43.1** — Мигрень с аурой [классическая мигрень] **G43.2** — Мигренозный статус **G43.3** — Осложненная мигрень **G43.8** — Другая мигрень **G43.9** — Мигрень неуточненная **G44.0** — Синдром «гистаминовой» головной боли **G44.1** — Сосудистая головная боль, не классифицированная в других рубриках **G44.4** — Головная боль, вызванная применением лекарственных средств, не классифицированная в других рубриках
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 15.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Всероссийское общество неврологов; Ассоциация Здоровье детей; Российское межрегиональное общество по изучению боли (РОИБ)
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/169_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения **3**

2. Клиническая картина и классификация **3**

2.1 Определение 3

2.2 Этиология и эпидемиология 3

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика **5**

3.1 Критерии диагноза 5

3.2 Жалобы и анамнез 6

3.3 Физикальное обследование 6

3.4 Лабораторные исследования 6

3.5 Нейровизуализация и ЭЭГ 6

3.6 Дневник головной боли и дифференциальная диагностика 7

4. Лечение **7**

4.1 Купирование приступа 8

4.2 Немедикаментозное лечение 8

4.3 Профилактическое лечение 8

4.4 Медицинская реабилитация 10

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации **10**

5.1 Показания к госпитализации 10

6. Источник и актуальность **10**

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 11

1. Основные положения

- Мигрень — первичная головная боль с повторяющимися приступами, которые часто сопровождаются тошнотой, рвотой, фото- и фонофобией; у детей боль чаще двусторонняя. Приступ длится от **1 часа (до 6 лет)** — **2 часов (старше 7 лет)** до нескольких суток и обычно прекращается со сном.
- Диагноз ставят исключительно клинически по критериям МКГБ-3; лабораторные и инструментальные исследования при типичной картине и нормальном неврологическом статусе не рекомендуются. МРТ головного мозга показана при редких формах ауры, осложнениях мигрени и «сигналах опасности».
- Для оториноларинголога: доброкачественное пароксизмальное головокружение детского возраста — эпизодический синдром, сочетающийся с мигренью; при мигрени со стволовой аурой возможны головокружение, шум в ушах, гипакузия.
- Приступ купируют ибупрофеном или парацетамолом в самом начале; обезболивающие **не более 2 (максимум 3) раз в неделю**. Триптаны в России разрешены **с 18 лет**, до 18 лет — с осторожностью по решению врачебной комиссии. Профилактическое лечение рассматривают при **2 и более приступах в месяц**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Мигрень (М) — одна из наиболее распространённых форм первичной головной боли, проявляющаяся повторяющимися приступами, которые часто сопровождаются тошнотой, рвотой, фото- и фонофобией.

Боль чаще односторонняя (гемикрания), сторона может меняться; у детей часто двусторонняя. Боль интенсивная и усиливается при лёгкой физической нагрузке.

Приступ длится от 1 часа **у детей до 6 лет** и от 2 часов **у детей старше 7 лет** до нескольких суток; обычно прекращается с наступлением сна.

2.2 Этиология и эпидемиология

Большое значение имеют наследственные факторы: моногенные формы — семейная гемиплегическая мигрень I–III типов (гены CACNA1A, ATP1A2, SCN1A) — встречаются крайне редко (0,01%); в большинстве случаев наследуется предрасположенность.

Мигрень считается нейроваскулярной головной болью: распространяющаяся волна корковой депрессии активирует тригеминоваскулярную систему с выбросом CGRP и нейрогенным воспалением.

Триггеры приступа

1. **психологические** — стрессы, эмоции, изменения настроения
2. **гормональные** — менструация, овуляция
3. **окружающая среда** — яркий свет, громкий шум, резкие запахи, погодные условия
4. **питание** — горький шоколад, твёрдые сыры, помидоры, киви, орехи, лук, чеснок, алкоголь, продукты с глутаматом, нитритами и нитратами, сладкие газированные напитки
5. **лекарства** — резерпин, нитроглицерин, эстрогены
6. **другие** — недосыпание или пересыпание, голод и нерегулярное питание, гипогликемия, гипертермия, усталость, авиаперелёты

В 7 лет распространённость мигрени — 1,2–3,2%, в 7–11 лет — 4–11%, у детей старше 11 лет и подростков — 8–23%; в 15–19 лет — около 28%.

2.3 Классификация

Классификация мигрени (МКГБ-3, 2018)

1. мигрень без ауры;
2. мигрень с аурой: с типичной аурой, со стволовой аурой, гемиплегическая (семейная, спорадическая), ретинальная;
3. хроническая мигрень;
4. осложнения мигрени: мигренозный статус, персистирующая аура без инфаркта, мигренозный инфаркт, аура — триггер эпилептического припадка;
5. возможная мигрень;
6. эпизодические синдромы, которые могут сочетаться с мигренью: синдром циклических рвот, абдоминальная мигрень, доброкачественное пароксизмальное головокружение, доброкачественный пароксизмальный тортиколлис.

2.4 Клиническая картина

Мигрень без ауры — приступы цефалгии продолжительностью **4–72 часа** (у детей от 2 часов) со специфическими сопровождающими симптомами; наблюдается примерно у половины больных мигренью.

Диагностические критерии мигрени без ауры (МКГБ-3)

1. A. Не менее 5 приступов, отвечающих критериям B–D.
2. B. Продолжительность **4–72 часа** (**у детей до 15 лет — 2–48 часов**) без лечения или при его неэффективности.
3. C. Не менее 2 признаков: односторонняя локализация; пульсирующий характер; средняя или значительная интенсивность; ухудшение от обычной физической активности.
4. D. Не менее 1 симптома: тошнота и/или рвота; фотофобия и одновременно фонофобия.

Мигрень с аурой характеризуется повторяющимися эпизодами обратимых локальных неврологических симптомов, которые нарастают **в течение 5–20 минут** и продолжаются **не более 60 минут**; за аурой, как правило, следует головная боль.

Диагностические критерии мигрени с аурой (МКГБ-3)

1. A. Не менее 2 приступов, отвечающих критериям B–D.
2. B. Хотя бы один полностью обратимый симптом ауры без двигательной слабости: зрительный, чувствительный, нарушение речи.
3. C. Не менее 2 признаков: гомонимные зрительные или односторонние чувствительные симптомы; постепенное развитие или последовательное возникновение симптомов **не менее 5 минут**; каждый симптом длится **от 5 до 60 минут**.
4. D. Головная боль, соответствующая мигрени без ауры, начинается во время ауры или **в течение 60 минут** после её начала.

1. **ретинальная мигрень** — повторяющиеся монокулярные расстройства зрения (мерцание, скотома, слепота) с мигренозной болью; исключают невропатию зрительного нерва, расслоение сонной артерии, патологию центральной артерии сетчатки
2. **гемиплегическая мигрень** — помимо ауры — полностью обратимая мышечная слабость
3. **мигрень со стволовой аурой** — не менее 2 симптомов: дизартрия, головокружение, шум в ушах, гипакузия, диплопия, атаксия, нарушение уровня сознания

1. **хроническая мигрень** — приступы **не менее 15 дней в месяц** на протяжении **не менее 3 месяцев** при эпизодической мигрени в анамнезе
2. **мигренозный статус** — приступ или серия приступов **более 72 часов** (исключая сон); как правило, показание к госпитализации
3. **персистирующая аура без инфаркта** — симптомы ауры **более 7 дней** без инфаркта по нейровизуализации
4. **мигренозный инфаркт** — стойкая неврологическая симптоматика, аура **более 60 минут**, инфаркт подтверждён нейровизуализацией

В детском возрасте относительно часто отмечаются эпизодические синдромы — нередко предшественники классической мигрени в старшем возрасте.

1. **синдром циклических рвот** — не менее 5 стереотипных приступов интенсивной тошноты и рвоты (не реже 4 раз в час, **от 1 часа до 10 дней**), интервал **не менее 1 недели**, между приступами ЖКТ без нарушений

1. **абдоминальная мигрень** — не менее 5 приступов боли в животе по средней линии, умеренной или сильной, с анорексией, тошнотой, рвотой, бледностью, **2–72 часа**; головная боль не характерна

1. **доброкачественный пароксизмальный тортиколлис** — приступы с повышенной возбудимостью, недомоганием, рвотой, атаксией; как правило, ежемесячно

Доброкачественное пароксизмальное головокружение — повторяющиеся кратковременные приступы головокружения у здоровых детей, возникающие спонтанно и проходящие самостоятельно.

Диагностические критерии (МКГБ-3)

1. A. Не менее 5 приступов, соответствующих критериям B и C.
2. B. Головокружение возникает спонтанно, максимально выражено в начале и проходит самостоятельно через минуты или часы, без потери сознания.
3. C. Не менее 1 признака: нистагм, атаксия, рвота, бледность, ощущение боязни.
4. D. Между приступами нет патологии в неврологическом статусе, при аудиометрии и исследовании вестибулярной функции.
5. E. Нет другого заболевания со сходной картиной.

Маленькие дети не могут описать головокружение: эпизоды нарушения равновесия, замеченные родителями, могут быть его проявлением. Должны быть исключены опухоли задней черепной ямки, эпилептические пароксизмы, заболевания вестибулярной системы.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз основан на жалобах пациента и родителей, анамнезе, неврологическом осмотре и исключении других причин головной боли; клиническая картина должна соответствовать критериям МКГБ-3.

1. **достоверный диагноз** — соответствие всем критериям мигрени с аурой или без ауры
2. **вероятный диагноз** — несоответствие по одному критерию
3. **возможный диагноз** — несоответствие по нескольким критериям

3.2 Жалобы и анамнез

Детям с головной болью проводится тщательный сбор анамнеза, общеклиническое и неврологическое обследование.

Предвестники приступа (за несколько часов или дней)

1. эмоциональные нарушения: раздражительность, депрессия, апатия;
2. нарушение сна;
3. изменения аппетита;
4. жажда и задержка жидкости.

У большинства детей с мигренью без ауры приступы — **1 раз в 1–2 месяца**, при мигрени с аурой реже, при гемиплегической — 1 раз в 4–6 месяцев.

У детей боль бывает давящей, распирающей или ломящей и локализуется в лобной, лобно-височной или периорбитальной области. У дошкольников она, как правило, двусторонняя, у старших детей — односторонняя со сменой сторон; только к 10–12 годам характеристики соответствуют взрослым.

Во время приступа характерны бледность, скудная мимика, тошнота, реже рвота, после которой ребёнок обычно засыпает; после сна приступ купируется. Приступ длится в среднем 2–3 часа без ауры и около часа с аурой. Между приступами дети практически здоровы.

3.3 Физикальное обследование

Интенсивность боли в приступе у пациентов **с 7 лет** оценивают по визуальной аналоговой шкале (ВАШ); у младших — по шкалам с изображением лиц или цветов.

Обычно боль достигает 7–9 баллов. Нередко отмечаются общая гиперестезия, фото- и фонофобия, особая чувствительность к запахам и прикосновениям.

3.4 Лабораторные исследования

Лабораторные исследования для диагностики мигрени не рекомендуются.

Для исключения мигренеподобной боли при метаболических расстройствах определяют гомоцистеин, витамин B12, фолиевую кислоту, лактат и пируват сыворотки крови.

3.5 Нейровизуализация и ЭЭГ

При соответствии критериям и нормальном неврологическом статусе инструментальные исследования не рекомендуются.

ЭЭГ при типичной картине без подозрения на эпилептический генез не рекомендуется.

При редких формах ауры (ретинальная, пролонгированная, стволовая) и осложнениях мигрени показаны МРТ головного мозга и МР-ангиография — для исключения аномалий развития сосудов головного мозга.

При нетипичном течении или «сигналах опасности» показаны МРТ, МР-ангиография или КТ головного мозга.

«Сигналы опасности»

1. головная боль, изменившая течение;
2. «громоподобная» боль, нарастающая до 10 баллов по ВАШ **за 1–2 секунды**;
3. строго односторонняя боль;
4. прогрессивно ухудшающаяся боль без ремиссий;
5. внезапная, необычная для пациента боль;
6. атипичная аура: необычные нарушения и/или продолжительность **более 1 часа**;
7. изменения сознания или психические нарушения;
8. очаговые симптомы и симптомы системного заболевания при впервые возникшей боли;
9. признаки внутричерепной гипертензии;
10. отёк диска зрительного нерва;
11. ВИЧ-инфекция, онкологическое, эндокринное, системное заболевание или травма головы в анамнезе;
12. неэффективность адекватного лечения;
13. очаговая симптоматика в неврологическом статусе;
14. нарастающая боль с тошнотой или рвотой, усиливающаяся при изменении положения головы.

Негрубые сосудистые аномалии, изменения белого вещества, арахноидальные и эпифизарные кисты клинического значения у детей с головной болью не имеют, но требуют разъяснений семье. Если родители связывают начало боли с травмой шеи, показана МР-ангиография сосудов головы и шеи для исключения диссекции сонной артерии; при признаках внутричерепной гипертензии исключают тромбоз венозных синусов.

При подозрении на эпилептический генез — короткий приступ после сна с тошнотой и однократной рвотой, кратковременные вегетативные или зрительные нарушения, ночная боль с последующей вялостью — показана ЭЭГ с видеомониторингом, в том числе во сне.

Детям с головной болью проводится офтальмоскопия для исключения застойных явлений на глазном дне; их выявление — показание к МРТ или КТ головного мозга.

3.6 Дневник головной боли и дифференциальная диагностика

Ведётся дневник головной боли: длительность и интенсивность, сопутствующие симптомы, триггеры, приём лекарств.

Главная задача — разграничить первичную и вторичную головную боль.

1. размер и форма головы: субкомпенсированная гидроцефалия сопровождается частыми болями;
2. острое начало нередко связано с системными инфекциями (ОРВИ, грипп, менингит) и органическим поражением мозга;
3. повторяющиеся приступы без нарастания и без изменений неврологического статуса указывают на первичную боль, в том числе мигрень;
4. головная боль напряжения отличается лёгкой или умеренной двусторонней давящей болью, не усиливающейся при нагрузке.

---

4. Лечение

Выделяют лечение приступа и профилактическое лечение. Дети часто пропускают начало приступа, поэтому детей и родителей обучают раннему распознаванию приступа и его лечению.

4.1 Купирование приступа

При приступах умеренной и высокой интенсивности применяется ибупрофен в самом начале приступа; у старших детей в исследованиях применялась доза 7,5 мг/кг.

1. дети: 10 мг/кг на приём

Парацетамол применяется в самом начале приступа.

1. дети: 10–15 мг/кг на приём
2. повторно: **через 6–8 часов**

При частых приступах обезболивающие **более 2 (максимум 3) раз в неделю** не рекомендуются из-за риска лекарственного абузуса.

При приступах умеренной интенсивности назначают НПВП (ибупрофен, парацетамол), при тяжёлых приступах (более 8 баллов по ВАШ) и неэффективности НПВП — триптаны или эрготамин в комбинации, исключая психолептики. Триптаны в России разрешены **с 18 лет**.

До 18 лет триптаны применяют с осторожностью при неэффективности других препаратов по решению врачебной комиссии с информированным согласием. Эффективность пероральных триптанов у детей однозначно не доказана, назальные формы эффективнее.

1. #суматриптан, масса **менее 40 кг**: 12,5–25 мг на приём
2. #суматриптан, масса **более 40 кг**: 50–100 мг
3. #золмитриптан (таблетки, назальный спрей 2,5 мг/доза): 2,5 мг при массе менее 40 кг, 5 мг — более 40 кг
4. #ризатриптан: 5 мг при массе менее 40 кг, 10 мг — более 40 кг

При выраженной тошноте и многократной рвоте в стационаре применяется #метоклопрамид внутривенно.

1. дети: 0,1 (0,13–0,15) мг/кг, максимум 10 мг

4.2 Немедикаментозное лечение

Всем пациентам с мигренью

1. режим сна;
2. регулярная оздоровительная спортивная нагрузка;
3. режим питания, достаточный объём жидкости, исключение пищевых провокаторов;
4. поведенческая терапия и психотерапевтическая коррекция: когнитивно-поведенческая терапия, биологическая обратная связь, релаксационные методы.

Когнитивно-поведенческая терапия включает психологическое консультирование, релаксационные тренинги, управление образом жизни и приверженность медикаментозной терапии.

Из дополнительных методов применяют биологическую обратную связь по электромиографическому или электроэнцефалографическому сигналу, общий массаж, иглорефлексотерапию.

4.3 Профилактическое лечение

Показания к профилактическому лечению

1. **2 и более** приступа мигрени в месяц;
2. тяжёлые и длительные приступы;
3. низкая эффективность купирующей терапии;
4. противопоказания или плохая переносимость препаратов для купирования;
5. необычная аура, пугающая ребёнка и родителей.

Изменение режима дня и образа жизни — всем пациентам

1. устранение или избегание триггеров;
2. релаксационная терапия;
3. гигиена сна;
4. исключение провоцирующих продуктов и уменьшение кофеинсодержащих напитков;
5. регулярная физическая нагрузка — **20–30 минут в день**.

Во время приступа рекомендуется отдых в затемнённой комнате; сон часто купирует приступ.

Всем пациентам показано динамическое наблюдение невролога по месту жительства.

Для профилактики у детей и подростков рекомендуются противоэпилептические препараты (наибольшее число исследований — по топирамату и вальпроевой кислоте). Минимальная продолжительность курса — **3 месяца**.

#Топирамат внутрь; при повышении дозы нарастают снижение аппетита и массы тела, парестезии, замедление когнитивных процессов, повышение образования солей в моче.

1. стартовая доза: 25 мг/сут
2. титрация: медленно в течение 8–10 недель до 2–3 мг/кг в сутки, максимум 100–200 мг/сут
3. курс: **не менее 3 месяцев**

#Вальпроевая кислота внутрь с медленной титрацией под контролем биохимических показателей функции печени и почек.

1. дети: 15–45 мг/кг/сут, эффективная доза 500–1000 мг/сут
2. минимальный курс: **3 месяца**

#Леветирацетам внутрь с постепенной титрацией.

1. целевая доза: 50 мг/кг/сут
2. масса **до 50 кг**: начало с 20 мг/кг/сут в 2 приёма, повышение на 10 мг/кг каждые 2 недели
3. масса **более 50 кг**: начало с 1000 мг/сут в 2 приёма, повышение на 500 мг 2 раза в сутки каждые 2–4 недели
4. длительность: **не менее 3 месяцев**

#Пропранолол внутрь под контролем частоты сердечных сокращений и артериального давления; противопоказан при бронхиальной астме, с осторожностью — при сахарном диабете, ортостатической гипотензии, депрессии.

1. начальная доза: 1 мг/кг/сут в 3 приёма
2. максимум: 4 мг/кг/сут
3. длительность: **не менее 3 месяцев**

#Циннаризин внутрь, лучше начинать с меньшей дозы; противопоказан при синдроме слабости синусового узла, АВ-блокаде 2–3 степени, сердечной недостаточности.

1. масса **менее 30 кг**: 1,5 мг/кг/сут
2. масса **более 30 кг**: 50 мг/сут
3. длительность: **не менее 3 месяцев**

#Амитриптилин внутрь на ночь; перед назначением — ЭКГ с физической нагрузкой. В последнее время применяется преимущественно при тяжёлом течении и хронической мигрени.

1. начальная доза: 0,25 мг/кг в сутки
2. повышение: **каждые 2 недели** до оптимальной 1 мг/кг/сут
3. длительность: **не менее 3 месяцев**

В качестве дополнительного лечения при низкой эффективности фармакотерапии применяют #рибофлавин 400 мг в день и #убидекаренон 150–300 мг в день курсом **2 месяца**.

Эффективна комбинация фармакологического и нефармакологического лечения (например, #амитриптилина с когнитивно-поведенческой терапией при хронической мигрени в 10–17 лет). Учитывают коморбидные тревожные и депрессивные расстройства.

Для предотвращения лекарственно-индуцированной головной боли простые анальгетики и НПВП ограничивают **не более 14 раз в месяц**, триптаны и сочетания триптанов с НПВП — **до 9 раз в месяц**.

Эффект оценивают по дневнику: снижение частоты приступов **на 50%** от исходного считается положительным эффектом профилактической терапии.

4.4 Медицинская реабилитация

При частых приступах и тяжёлом течении рекомендуется санаторно-курортное лечение **1–2 раза в год**: грязевые аппликации на воротниковую зону, радоновые или сероводородные ванны, лечебная физкультура, массаж.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Экстренная госпитализация в неврологическое отделение

1. головная боль с изменением сознания;
2. головная боль с лихорадкой и менингеальными симптомами;
3. нарастающая очаговая неврологическая симптоматика;
4. нарастающая общемозговая симптоматика;
5. мигренозный статус.

Плановая госпитализация

1. прогрессирующая головная боль;
2. некупируемая головная боль;
3. головная боль с аурой.

Критерии выписки

1. купирование головной боли;
2. уменьшение боли **до 3–4 баллов по ВАШ**.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Мигрень»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 15.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2027 года
Код в рубрикаторе	169_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Всероссийское общество неврологов; Российское межрегиональное общество по изучению боли; Ассоциация «Здоровье детей»
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Доза #топирамата: в тексте рекомендации — старт 25 мг/сут с титрацией до 2–3 мг/кг в сутки и максимумом 100–200 мг/сут, а в таблице 3 — «1–2 мг/кг/сутки (12,5–25 мг/сутки)». На странице приведена доза из рекомендации.